IPS GUAYACANES
NIT 900.000.333-3 · Código de habilitación 050010000333
Carrera 80 # 34-20, Medellín, Antioquia · Teléfono (604) 000 3333

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL
Registro de atención n.º GY-2026-010388

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
Nombres y apellidos: Martha Lucía Restrepo Gil
Documento: Cédula de ciudadanía 43.578.211
Fecha de nacimiento: 22/06/1979
Edad: 47 años
Sexo: Femenino
Estado civil: Casada
Ocupación: Contadora pública
Dirección: Calle 33 # 76-15, barrio Laureles
Municipio de residencia: Medellín, Antioquia · Zona urbana
Teléfono: 300 615 2290
Aseguradora: EPS Antioquia Vital · Régimen contributivo, cotizante
Persona responsable: Carlos Mario Uribe Toro · Esposo · 304 118 5532

2. DATOS DE LA ATENCIÓN
Fecha y hora de inicio: 28/07/2026 11:00
Fecha y hora de fin: 28/07/2026 11:30
Modalidad: Presencial, en la sede
Servicio: Consulta externa de medicina general
Tipo de consulta: Control
Finalidad de la consulta: Tratamiento
Causa que motiva la atención: Enfermedad general
Acompañante: Asiste sola

3. MOTIVO DE CONSULTA
"Traigo lo de ginecología, y me duele la espalda baja."

4. ENFERMEDAD ACTUAL
Trae resultados de ginecología: histeroscopia del 18/05/2026 con resección de un pólipo endometrial; patología del 26/05/2026: pólipo endometrial benigno, sin atipia ni hiperplasia. El sangrado se resolvió después del procedimiento. Control en oncología el 15/06/2026: sin evidencia de enfermedad; oncología decide continuar el tamoxifeno con ecografía transvaginal cada año. Bochornos controlados con venlafaxina.
Desde hace 3 semanas presenta dolor en la parte baja de la espalda, en el centro, que empezó después de cargar cajas en una mudanza. Empeora al agacharse y al estar sentada mucho tiempo, mejora con el reposo, intensidad 6 sobre 10. No se irradia a las piernas. Niega dolor en la noche o en reposo, pérdida de peso, fiebre, debilidad en las piernas y cambios al orinar o al defecar. Ha tomado acetaminofén con alivio parcial.

5. ANTECEDENTES
Personales patológicos: Carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda, estadio IIA, receptores hormonales positivos y HER2 negativo, diagnosticado en marzo de 2023. Sin evidencia de enfermedad en junio de 2026. Bochornos por tamoxifeno, controlados. Pólipo endometrial benigno resecado en mayo de 2026.
Quirúrgicos: Cesáreas en 2008 y 2011. Cuadrantectomía izquierda en 2023. Histeroscopia con resección de pólipo endometrial en mayo de 2026.
Farmacológicos actuales: Tamoxifeno 20 mg al día. Venlafaxina 37,5 mg en la mañana.
Alérgicos:

- Medicamentoso: penicilina (urticaria generalizada en 2010). No tiene alergia a antiinflamatorios.
- Alimentarios: no refiere.
- Ambientales: no refiere.

Tóxicos y factores de riesgo: No fuma. Alcohol ocasional. Trabajo sentada 8 a 9 horas al día.
Gineco-obstétricos: Gestaciones 2, cesáreas 2. Dispositivo intrauterino de cobre. Fecha de última menstruación: 12/07/2026.
Familiares: Madre con cáncer de mama a los 55 años. Tía materna con cáncer de ovario a los 60 años. Padre con diabetes tipo 2.

6. REVISIÓN POR SISTEMAS
Osteomuscular: dolor lumbar, descrito en la enfermedad actual.
Genitourinario: sin sangrado anormal desde mayo.
Demás sistemas: sin hallazgos.

7. SIGNOS VITALES Y MEDIDAS
Tensión arterial: 120/76 mmHg
Frecuencia cardiaca: 74 latidos por minuto
Frecuencia respiratoria: 15 respiraciones por minuto
Temperatura: 36,6 °C
Saturación de oxígeno: 98 % al aire ambiente
Peso: 65,2 kg
Talla: 1,63 m
Índice de masa corporal: 24,5 kg/m²

8. EXAMEN FÍSICO
Aspecto general: buen estado general, camina sin ayuda.
Mamas y axilas: sin masas ni ganglios.
Columna: contractura de los músculos a ambos lados de la columna lumbar. Sin dolor a la percusión de las vértebras. Flexión limitada por dolor.
Neurológico: prueba de Lasègue negativa en ambas piernas. Fuerza, sensibilidad y reflejos normales en las piernas. Marcha en puntas y talones normal.
Extremidades: sin edema.

9. RESULTADOS DE PARACLÍNICOS
Histeroscopia del 18/05/2026: pólipo endometrial de 8 mm, resecado por completo.
Patología del 26/05/2026: pólipo endometrial benigno, sin atipia ni hiperplasia.
Control de oncología del 15/06/2026: sin evidencia de enfermedad. Continúa tamoxifeno.

10. ANÁLISIS
El sangrado de abril se explicó por un pólipo endometrial benigno, ya resecado. Presenta dolor lumbar de características mecánicas después de un esfuerzo, sin signos neurológicos. Aunque el cuadro parece muscular, el antecedente de cáncer de mama es una señal de alarma para dolor de espalda, porque este cáncer puede extenderse al hueso. Por eso se piden radiografía y laboratorios aunque el examen sea tranquilizador. Puede recibir antiinflamatorios: su alergia es solo a la penicilina.

11. DIAGNÓSTICOS (CIE-10)
Principal: M54.5 Lumbago no especificado · Confirmado nuevo
Relacionado: Z85.3 Historia personal de tumor maligno de la mama · Confirmado repetido
Relacionado: Z86.0 Historia personal de otros tumores (pólipo endometrial benigno resecado) · Confirmado nuevo

12. PLAN DE MANEJO

12.1 Fórmula médica

1. Naproxeno 250 mg tableta. Una tableta por vía oral cada 12 horas, con comida. Duración: 5 días. Cantidad: 10 tabletas.
2. Acetaminofén 500 mg tableta. Dos tabletas por vía oral cada 8 horas. Duración: 7 días. Cantidad: 42 tabletas.
3. Metocarbamol 750 mg tableta. Una tableta por vía oral cada 8 horas. Duración: 5 días. Cantidad: 15 tabletas.
4. Venlafaxina 37,5 mg cápsula de liberación prolongada. Una cápsula por vía oral en la mañana. Duración: 90 días. Cantidad: 90 cápsulas.

Continúa tamoxifeno 20 mg al día, formulado por oncología.

12.2 Órdenes de exámenes y procedimientos
- Radiografía de columna lumbosacra, proyecciones anteroposterior y lateral.
- Fosfatasa alcalina, calcio sérico, hemograma y velocidad de sedimentación globular.

12.3 Remisiones e interconsultas
- Ninguna en esta consulta. Si la radiografía o los laboratorios salen alterados, se remite a oncología con prioridad.

12.4 Incapacidad
Dos días: 28/07/2026 y 29/07/2026.

12.5 Recomendaciones y educación
Calor local 20 minutos tres veces al día. Mantenerse activa y caminar; no hacer reposo en cama. Al volver al trabajo, pausas activas cada hora y silla con apoyo lumbar. No cargar objetos pesados por dos semanas. El metocarbamol puede dar sueño.

12.6 Signos de alarma
Dolor que aparece de noche o en reposo, debilidad o adormecimiento en las piernas, pérdida del control de la orina o de las heces, fiebre o pérdida de peso sin explicación: consultar de inmediato.

12.7 Próximo control
En 2 semanas, con la radiografía y los laboratorios.

13. DESTINO AL FINALIZAR LA ATENCIÓN
Domicilio.

14. PROFESIONAL QUE ATIENDE
Santiago Arango Vélez · Médico general
Cédula de ciudadanía 71.385.902 · Registro médico 05-3381-12
Firmado electrónicamente el 28/07/2026 a las 11:30

Documento de prueba con datos inventados. No corresponde a ninguna persona ni institución real.
FIN DE LA HISTORIA